

Rapport de Situation de la 17^e Épidémie de la maladie à Virus Ebola / RDC

SitRep N°144 /MVE-BDBV/05/10/2026

Date du rapport : 05 octobre 2026

Date de publication : 06 octobre 2026



FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

Soixante-deux (62), 62 nouveaux cas confirmés de la Maladie à Virus Ebola (MVE), dont 20 décès communautaires ont été notifiés. Ces cas provenaient des provinces de l'Ituri (30 cas), du Nord-Kivu (26 cas), du Haut-Uélé (5 cas) et de la Tshopo (1 cas). De plus, 10 décès ont été enregistrés dans les CTE

- Un total de 311 nouveaux échantillons a été analysé ; 62 de ces échantillons se sont révélés positifs au virus Bundibugyo, soit 19,9% de positivité.

CUMUL DES CAS  8 665	CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS  4 178	LETALITE  48,2 %	PATIENTS EN ISOLEMENT/CTE  890	CUMUL DES GUÉRIS  2 259	TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour) 80,4%
---	---	---	---	--	--



Provinces touchées et zones de santé touchées



7 Provinces touchées

Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu,
Sud-Kivu, Tshopo, Bas-Uélé et
Sud Ubangi



64 Zones de santé touchées sur 167 (38,3%)

Résumé des points clés au cours des dernières 24 heures

Au cours des dernières 24 heures, 62 nouveaux cas confirmés de la Maladie à Virus Ebola (MVE) dont **20 décès communautaires** ont été notifiés dans 4 provinces : l'Ituri (30 cas), le Nord-Kivu (26 cas), le Haut-Uélé (5 cas) et la Tshopo (1 cas).

De plus, **10 décès ont été enregistrés dans les CTE** (6 en Ituri, 3 au Nord-Kivu et au Haut Uélé (1), ce qui porte à 30 le nombre total des décès confirmés pour la période considérée.

En revanche, **24 patients (17 en Ituri, 3 au Haut-Uélé, 2 au Bas-Uélé, 1 au Nord-Kivu et 1 au Sud Ubangi)** ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs au test de contrôle à la MVE.

En date du 05 octobre 2026, la RDC cumule **8 665 cas confirmés** et **4 178 décès**, soit une létalité de **48,2 %**. L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie avec **74,8 %** des cas confirmés cumulés et **48,4 %** des nouveaux cas confirmés rapportés au cours des dernières 24 heures.

64 zones de santé sur 167 (38,3 %), réparties dans **sept provinces**, ont été touchées depuis le début de l'épidémie.

Tableau 1. Répartition des cas et décès confirmés par province touchée, au 05 octobre 2026.

Province	Nouveaux cas confirmés(24h)	Cas confirmés	Décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées
Ituri	30	6480	2 989	46,1%	28/36 (77,8 %)
Nord-Kivu	26	1755	1 013	57,7%	17/34 (50,0 %)
Haut-Uélé	5	364	153	42,0%	7/13 (53,8 %)
Tshopo	1	51	17	33,3%	7/23 (30,4 %)
Sud-Kivu	0	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)
Bas-Uélé	0	10	4	40,0%	3/11 (27,3%)
Sud Ubangi	0	2	1	50,0%	1/16 (6,3%)
Total	62	8 665	4 178	48,2%	64/167 (38,3 %)

Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone au 05 octobre 2026

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	6480	2989	46,1%	30	15	6	21
Adja	11	1	9,1%				0
Aru	8	6	75,0%				0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	210	46	21,9%	2			0
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	1783	588	33,0%	4	2	2	4
Damas	40	9	22,5%				0
Drodoro	15	7	46,7%				0
Fataki	83	31	37,3%				0
Gethy	9	5	55,6%				0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	38	12	31,6%				0
Komanda	175	107	61,1%				0
Lita	294	147	50,0%				0
Logo	14	5	35,7%	1	0	0	0
Lolwa	34	9	26,5%	0	0	0	0
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	37	16	43,2%				0
Mandima	195	97	49,7%	19	13		13
Mangala	365	157	43,0%			0	0
Mongbwalu	707	336	47,5%			1	1
Nia-Nia	311	175	56,3%				0
Nizi	788	282	35,8%	2			0
Nyankunde	130	37	28,5%				0
Rimba	14	5	35,7%	1			0
Rwampara	1115	383	34,3%	1		3	3

Tchomia	76	25	32,9%					0
A ventiler	NA	493	NA					0
Nord-Kivu	1755	1013	57,7%	26	5	3		8
Beni	400	264	66,0%	7	3	1		4
Biena	20	7	35,0%					0
Butembo	283	180	63,6%	3	0			0
Goma	1	0	0,0%					0
Kalunguta	61	21	34,4%	1	0			0
Katwa	606	372	61,4%	6	1	1		2
Kayna	3	2	66,7%					0
Kyondo	36	20	55,6%					0
Lubero	22	11	50,0%					0
Mabalako	51	20	39,2%	5	1	1		2
Alimbongo	4	2	50,0%					0
Manguredjipa	13	5	38,5%					0
Masereka	32	11	34,4%					0
Musienene	138	69	50,0%					0
Mutwanga	17	3	17,6%	1	0			0
Oicha	33	16	48,5%	2	0			0
Vuhovi	35	10	28,6%	1	0			0
Haut-Uélé	364	153	42,0%	5	0	1		1
Boma Mangbetu	43	19	44,2%	0	0	1		1
Dungu	1	1	100,0%					0
Gombari	3	1	33,3%					0
Isiro	102	44	43,1%					0
Pawa	92	43	46,7%	2	0			0
Rungu	4	2	50,0%					0
Wamba	119	43	36,1%	3	0			0
Tshopo	51	17	33,3%	1	0	0		0
Bafwasende	7	1	14,3%					0
Kabondo	5	1	20,0%					0
Lubunga	1	0	0,0%					0
Makiso-Kisangani	27	11	40,7%					0
Mangobo	8	3	37,5%					0
Tshopo	2	0	0,0%	1	0	0		0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%					0
Sud-Kivu	3	1	33,3%	0	0	0		0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%					0
Bas Uélé	10	4	40,0%	0	0	0		0
Buta	1	1	100,0%					0
Viadana	6	1	16,7%					0
Ganga	3	2	66,7%					0
Sud Ubangi	2	1	50,0%	0	0	0		0
Bulu	2	1	50,0%					0
Total	8665	4178	48,2%	62	20	10		30

*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province qui sont en cours de ventilation pour être classifiés par zone de santé.
NA : Non Applicable.

Tableau 3. Situation des alertes notifiées par province pour la journée du 05 octobre 2026

DPS	Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	64	3	67	12	3	52	0	15	3
Bas Uélé	187	3	190	29	3	158	0	32	0
Ituri	1 432	76	1508	164	75	1 268	1	239	132
Nord-Kivu	1 083	36	1119	168	32	915	4	200	133
Sud Ubangi	31	0	31	0	0	31	0	0	0
Tshopo	178	0	178	12	0	166	0	12	0
Total Général	2 975	118	3 093	385	113	2 590	5	498	268

Figure 1. Évolution de cas par date de début des symptômes au cours des 21 derniers jours

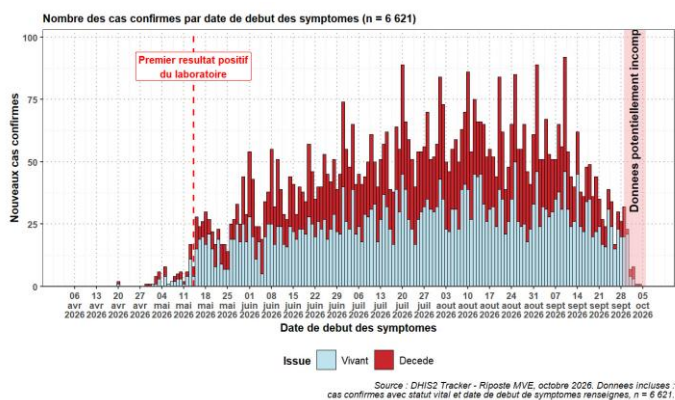
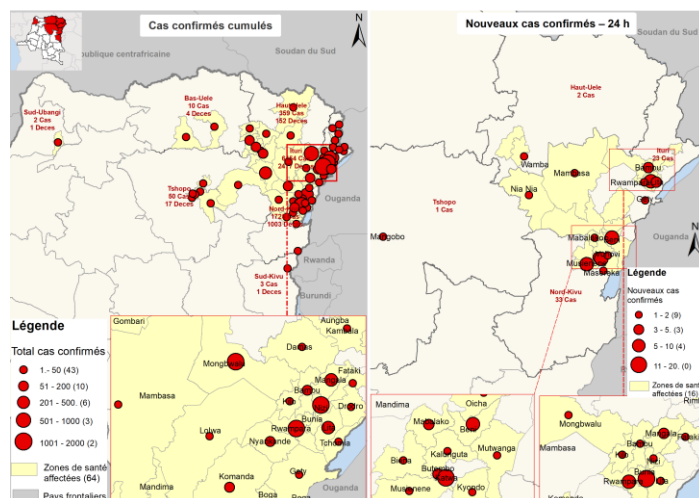


Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24 heures et cumuls) par zone de santé.



1. COORDINATION

1.1. Principales Actions

- Appui aux activités de réponse dans les provinces affectées à travers les piliers techniques.

2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

2.1. Surveillance épidémiologique

2.1.1. Principales Actions

Pour la journée du 05 octobre 2026, **3 093 alertes (100 %)** ont été vérifiées, dont **498 (16,1 %)** ont été validées comme cas suspects et **2 595 (83,9 %)** invalidées. Les 498 cas suspects validés ont tous été investigués (**100 %**). Parmi eux, **268** ont été transférés vers les CT/CTE. Parmi **29 535 contacts en cours de suivi**, **23 741** ont été vus au cours des dernières **24 heures**, soit une proportion de suivi de **80,4 %**, en hausse par rapport à la veille (**79,7 %**), mais toujours inférieure au seuil requis de **95,0 %**. Cette proportion était de **83,4 % (10 703/12 830)** en Ituri, **76,8 % (10 584/13 790)** au Nord-Kivu, **85,6 % (1 616/1 888)** au Haut-Uélé, **80,2 % (679/847)** à la Tshopo, **86,8 % (118/136)** au Bas-Uélé et **93,2 % (41/44)** au Sud-Ubangi.

2.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoE/PoC)

2.2.1. Principales actions

Deux (2) alertes ont été notifiées aux PoE/PoC au cours de la journée du 05 octobre, dont une (1) en Ituri et une (1) au Nord-Kivu. En Ituri, un corps sans vie de sexe féminin, en provenance de l'Ouganda et à destination de Tchomia pour l'enterrement, a été intercepté au PoC de Tchomia (AS Kikosa, ZS de Tchomia), puis validé et swabé, le résultat étant en attente (corps sans vie swabés/sécurisés : 100,0 % ; 1/1). Au Nord-Kivu, l'alerte notifiée au PoC PK5 concernait un chauffeur ougandais de 33 ans, en provenance de Beni et à destination de l'Ouganda, présentant des vomissements, une diarrhée, des frissons et une asthénie ; validée comme cas suspect, elle n'a pas pu être évacuée faute d'ambulance (taux de transfert : 0,0 % ; 0/1)

Tableau 4. Situation indicateurs clés des PoE/PoC par province, en date du 05 octobre 2026

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Tshopo	Global
Complétude des rapports	96,7% (58/60)	95,2% (20/21)	44,4% (8/18)	86,9% (86/99)
% des PoE/PoC stratégiques fonctionnels	100%	100%	100%	100%
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	156 717	99 704	9 107	265 528
% des voyageurs screenés	96,0%	97,6%	97,4%	96,6%
% des voyageurs ayant lavé les mains	91,1%	97,6%	97,7%	93,7%
% des voyageurs sensibilisés	99,2%	97,6%	100,0%	98,6%
Nombre d'alertes notifiées	1	1	0	2
Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects)	0	1	0	1
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	1	0	0	1
% des cas suspects transférés au CTE/CT	NA	0,0%	NA	0,0%
% des corps sans vie swabés/sécurisés	100,0%	NA	NA	100,0%
% des cas suspects investigués dans 4 h	NA	100,0%	NA	100,0%

2.2.2. Défis

À la Tshopo, la complétude des rapports reste faible (44,4 % ; 8/18), dix ports privés de Makiso-Kisangani ne fonctionnant pas le dimanche en raison des taxes élevées, et 2,6 % des voyageurs ont refusé le screening et 2,3 % le lavage des mains. En Ituri, 4,0 % des voyageurs n'ont pas été screenés et la proportion de voyageurs ayant lavé les mains a reculé à 91,1 % contre 97,2 % la veille. Au Haut-Uélé, 159 voyageurs (1,0 %) ont refusé le screening et 175 (1,1 %) le lavage des mains, principalement aux PoC de PK10 Route Poko, Magambe et Boh, sur fond de rumeurs selon lesquelles l'eau et les thermoflashes contiendraient le virus. Au Bas-Uélé, seuls 19 PoC sur 41 sites de notification sont fonctionnels (46,3 %), aucun PoE n'est renforcé (0/11) et les services du PNHF ne sont pas opérationnels.

2.3. Laboratoire

2.3.1. Principales actions

- **Ituri : 30 nouveaux résultats positifs** (15 vivants et 15 décès) sur 146 échantillons reçus et analysés (**positivité : 20,5 %**).
- **Nord-Kivu : 26 nouveaux résultats positifs** (21 vivants et 5 décès) sur 116 échantillons reçus et analysés (**positivité : 22,4%**).
- **Haut-Uélé : 5 nouveaux résultats positifs** (5 vivants) sur 25 échantillons reçus et analysés (**positivité : 20,0 %**).
- **Tshopo : 1 nouveau résultat positif reçu** (1 vivant) sur 14 échantillons reçus et analysés (**positivité : 7,1 %**).
- **Bas Uélé : 10 échantillons** (10 sangs) reçus et analysés au laboratoire de Buta, **tous sont revenus négatifs**.

2.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

2.4.1. Principales actions

- **Ituri** : 20 rings ont été ouverts sur 40 (50,0 %), 80 ménages décontaminés sur 80 (100 %) et 6 FOSA décontaminées sur 6 (100 %) ; aucun ménage, ESS ni école n'a été doté en kits. Sur 96 alertes EDS (dont 6 reports), 59 EDS ont été réalisés (61,5 %) et 65 corps swabés ; 29 échecs et 8 reports ont été enregistrés en fin de journée.
- **Nord-Kivu** : 45 rings ont été ouverts sur 63 (71,4 %), 18 ménages décontaminés sur 63 (28,6 %) et 37 ESS décontaminées sur 61 (60,7 %) ; aucun des 18 ménages décontaminés n'a été doté en kit et 35 évaluations score card PCI ont donné un score moyen de 37,8 %. Sur 45 alertes EDS et 42 reports, 45 EDS ont été réalisés et 45 corps swabés. La formation de 40 PPL sur la PCI/WASH/EDS a été clôturée à Oicha avec l'appui de l'OMS et la paie de 10 équipes de décontamination et de 73 superviseurs de proximité a débuté avec l'appui de l'UNICEF.
- **Tshopo** : 2 rings ont été ouverts à Mangobo, 2 ESS (CS Salama et Clinique Kawaki, ZS de Mangobo) et les 2 ménages du cas n°48 ont été décontaminés, avec incinération de matelas, moustiquaires et draps ; 14 ESS sur 14 ont été suivies dans 5 ZS, avec 136 prestataires briefés (100 %). En cumul, 39 ESS sur 39 (100 %) et 30 ménages sur 33 (90,9 %) ayant accueilli un cas confirmé ont été décontaminés dans les 48 heures. Quant aux EDS, 2 alertes ont été reçues (CTE et HGR de Makiso-Kisangani), 1 EDS a été réalisé et 2 corps ont été swabés.
- **Bas-Uélé** : 13 ESS sur 13 (100 %) ont été suivies à Viadana (2), Buta (3) et Ganga (8), 29 prestataires sur 30 (96,7 %) et 25 hygiénistes sur 25 (100 %) ont été briefés ; la formation de 4 équipes EDS sur 4 s'est achevée à Buta avec l'appui de la Croix-Rouge, dont 3 sont déjà activées, et 3 swabs ont été réalisés à Dakwa, Koteli et Viadana.

2.4.2. Défis

À la Tshopo, 5 corps n'ont pas pu être swabés, les intrants PCI et les prestataires formés restent insuffisants et l'incinérateur de l'HGR de Makiso-Kisangani est toujours en panne. Au Bas-Uélé, la remontée des alertes de décès communautaires reste faible et tardive et les ESS manquent de zones de gestion des déchets, de latrines hygiéniques, de poubelles et de dispositifs de lavage des mains.

2.5. Prise en charge holistique

2.5.1. Principales actions

- **En Ituri**, 86 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 92 sorties, dont 17 guérisons, 65 non-cas et 10 décès (dont 6 confirmés). Au total, 366 patients demeuraient en isolement à la fin de la journée. Le taux d'occupation des lits était de 36,1 % ; 312 patients sur 345 (90,4 %) ont bénéficié de repas chauds et les enfants sous LNPE/SLM ont été intégralement couverts au CTE (13/13), à la crèche (6/6) et dans la communauté (46/46) ; 37 malades sont en état critique.
- **Au Nord-Kivu**, 155 nouvelles admissions (21 confirmés et 134 suspects) ont été enregistrées contre 85 sorties, dont 1 guérison à Katwa, 78 non-cas et 6 décès (3 confirmés et 3 suspects). Au total, 417 patients (139 confirmés et 278 suspects) demeuraient hospitalisés, dont 271 dans les structures normées. Le taux d'occupation des lits était de **74,2 %** (271/365) ; 118 malades ont bénéficié de repas chauds, 16 nourrissons séparés sont sous substitut de lait maternel (100 %) et 3 malades étaient en état critique (CTE de Beni et de Kitatumba) ; 10 ambulances sur 14 ont été utilisées et les 33 courses demandées ont toutes été réussies.
- **À la Tshopo**, 3 nouvelles admissions (1 confirmé et 2 suspects) ont été enregistrées contre 2 sorties de non-cas. 18 patients (8 confirmés et 10 suspects) demeuraient en isolement à la fin de la journée, soit un taux d'occupation de 50,0 % (18/36 lits) ; les 18 patients et 47 PPL ont bénéficié de repas chauds et 260 personnes ont reçu la prophylaxie post-exposition depuis le début de la riposte.
- **Au Bas-Uélé**, 29 nouvelles admissions de suspects ont été enregistrées dans les sites d'isolement non normés de Ganga-Dingila (12), Bondo (7), Poko (5), Buta (3) et Limba (2), contre 2 sorties de guéris à Limba ; 29 suspects demeuraient en isolement à la fin de la journée
- **Au Haut-Uélé**, 9 nouvelles admissions (3 confirmés et 6 suspects) ont été enregistrées contre 8 sorties (7 non-cas et 1 décès confirmé au CTE de Boma Mangbetu). Au total, 60 patients (31 confirmés et 29 suspects) sont en isolement dans les CTE, soit un taux d'occupation de 39,2 %

(60/153 lits) ; 3 guéris sont sortis des CTE d'Isiro (1) et de Wamba (2) et 57 patients, 76 accompagnants et 80 PPL ont bénéficié de repas chauds.

2.5.2. Défis

- **En Ituri**, la faible capacité d'accueil des CTE/CT de Mambasa, Kilo, Mangala, Mandima, Sota et Lolwa, la présence de 37 malades critiques et l'absence de prise en charge alimentaire pour 33 patients à Lolwa (14), Mambasa (9) et Mandima (10) demeurent préoccupantes.
- **Au Bas-Uélé**, l'absence de CTE normé et d'ambulance pour le transfert des malades demeure un défi opérationnel majeur.
- **À la Tshopo**, l'absence de kit et de lit d'accouchement et d'échographe au CTE, l'insuffisance de lits au centre de traitement expérimental de Makiso-Kisangani et la démotivation de 12 ambulanciers sur 29 (41,4 %) fragilisent la prise en charge.

2.6. Vaccination

2.6.1. Principales actions

- **Au Bas-Uélé**, la vaccination des PPL et TPL s'est poursuivie dans les ZS de Buta, Aketi et Viadana, avec le préenregistrement des leaders religieux, RECO, tradipraticiens, motards et chasseurs, portant le cumul provincial à 1 333 personnes vaccinées sur une cible de 13 202 (10,1 %), principalement à Buta (620 ; 21,6 %) et à Ganga (273 ; 20,5 %).
- **À la Tshopo**, 4 ZS sur 5 ont été servies en vaccin Ervebo (Makiso-Kisangani : 400 doses, Tshopo : 100, Mangobo : 50 et Kabondo : 50) et la vaccination a démarré dans les ZS de Makiso-Kisangani et de Mangobo.

2.6.2. Défis

À la Tshopo, les ZS de Tshopo et de Kabondo, pourtant servies en vaccins, n'ont pas encore démarré la vaccination.

Au Bas-Uélé, la mise en marche des UCC n'est pas effective, le micro-plan validé et les fonds de la vaccination ne sont pas disponibles et le véhicule de l'équipe de vaccination déployé à Viadana doit être dépanné et approvisionné en carburant.

2.7. Continuité des Soins

2.7.1. Principales actions

- **À la Tshopo**, l'évaluation du CS Sendwe (AS Malkia, ZS de Tshopo), d'où provient le 18e PPL confirmé, a révélé qu'aucun agent n'était vacciné (0/11), l'absence de plusieurs registres, la non-utilisation du partogramme, l'absence d'incinérateur et de trou à placenta et une zone de triage non effective ; le plan de redressement du CS Boyoma a été élaboré et le suivi des PPL au CTM et au CTE ainsi que celui des guéris présentant des comorbidités à l'HGR de Makiso-Kisangani se sont poursuivis.
- **Au Bas-Uélé**, l'ESS de Limba (ZS de Viadana) a été évalué sur la fonctionnalité des organes de gestion et de participation communautaire, en comparant les recettes et les réunions des CODI et CODESA tenues de mai à septembre 2025 et 2026

2.8. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC)

2.8.1. Principales actions

- **En Ituri**, 23 782 visites à domicile ont touché 105 316 personnes ; 998 causeries éducatives ont réunis 20 218 personnes, 112 sensibilisations de masse ont touché 6 153 personnes et 5 plaidoyers 29 autorités et leaders. Au total, 389 alertes communautaires, dont 142 décès, ont été notifiées ; 308 feedbacks sur 319 (96,6 %) ont été recueillis et 5 incidents sur 6 (83,3 %) ont été résolus dans les 48 heures
- **Au Nord-Kivu**, 10 654 visites à domicile ont touché 34 721 personnes, 230 causeries éducatives ont touché 7 449 personnes et 63 séances de communication de masse ont atteint 8 368 personnes ; 201 alertes communautaires sur 750 attendues (26,8 %) ont été notifiées, 13 feedbacks sur 17 (76,5 %) ont été résolus dans les 48 heures et 910 personnes sur 4 750 attendues (19,2 %) se sont engagées dans les actions communautaires.
- **À la Tshopo**, 47 270 personnes (21 092 hommes et 26 178 femmes) ont été sensibilisées lors de 7 séances de masse à Bafwasende, Tshopo, Mangobo et Makiso-Kisangani, 3 causeries éducatives ont touché 187 personnes et un débat communautaire, avec le témoignage d'un guéri, a réuni 104 personnes à la paroisse Christ-Roi de Mangobo ; 4 émissions ont été animées, 258 affiches et 121 dépliants distribués.

2.9. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

2.9.1. Principales actions

- **Nord-Kivu, 30** derniers cas confirmés sur 33 (90,9 %), 246 confirmés en cours de suivi, 223 nouveaux suspects et 676 suspects en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS. Les équipes ont accompagné 66 ménages pour les actions de santé publique, soutenu 87 PPL, suivi 8 guéris sur 8 en communauté (100 %), réalisé la psychoéducation de 304 personnes (117 hommes, 146 femmes et 41 enfants) avec l'appui de l'UNICEF et annoncé 145 résultats, dont 39 positifs.
- **En Ituri, 18** cas confirmés sur 23 (78,3 %) de la veille, 111 confirmés en cours de suivi sur 121 (91,7 %), 42 nouveaux suspects sur 70 (60,0 %) et 105 suspects en cours de suivi sur 134 (78,4 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS. Les équipes ont soutenu 338 accompagnants et 43 PPL, suivi 20 guéris sur 24 (83,3 %) en communauté et 15 enfants sur 15 en crèche, accompagné 14 ménages d'enfants séparés et orphelins sur 17 (82,4 %), réinséré 11 guéris sur 16 (68,8 %) et annoncé 39 résultats, dont 18 positifs
- **À la Tshopo, le** nouveau cas confirmé et les 5 cas confirmés en cours de suivi au CTE Météo, ainsi que 6 nouveaux suspects sur 6 et 1 suspect en cours de suivi sur 1, ont été pris en charge (100 %) ; les équipes ont soutenu 17 PPL et 3 ménages, réinséré 1 guéri, réalisé la psychoéducation de 1 325 personnes, dont 1 244 à Bafwasende, levé 3 résistances sur 3 et annoncé 3 résultats, dont 1 positif ; 5 ZS sur 7 ayant notifié sont couvertes (71,4 %).
- **Au Haut-Uélé, 26** confirmés en cours de suivi, 7 nouveaux suspects et 22 suspects en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS dans les CTE d'Isiro, Pawa, Boma Mangbetu et Wamba ; les équipes ont soutenu 67 accompagnants, 61 PPL, 14 enfants séparés en communauté et 16 membres de ménages, appuyé 1 EDS et annoncé 12 résultats, dont 7 positifs.
- **Au Bas-Uélé, les** activités SMSPS se sont poursuivies dans la ZS de Viadana (Limba) : 1 PPL et 9 membres de ménages et de la communauté ont été soutenus, 2 guéris déchargés sont suivis et 1 résultat a été annoncé (négatif).

2.9.2. Défis

- **En Ituri, seules 14** ZS affectées sur 28 sont couvertes (50,0 %) et la ZS de Mandima n'a aucune couverture SMSPS, ce qui impose de renforcer les capacités des psychologues et des APS/TPS pour assurer les interventions autour des cas.
- **Au Bas-Uélé, la** couverture SMSPS reste embryonnaire, les activités venant à peine de démarrer dans la ZS de Viadana.
- **Au Haut-Uélé, la** mobilité des APS reste difficile à Wamba et à Boma Mangbetu, les kits nutritionnels manquent pour les nourrissons sevrés à Wamba et à Isiro, le pilier ne dispose pas de matériel informatique et la remontée des données reste faible à Boma Mangbetu et à Pawa
- **À la Tshopo, nécessité** de former les APS des ZS de Wanie-Rukula et de Bafwasende et insuffisance des unités de communication et des motos pour les déplacements du pilier.

2.10. Logistique

2.10.1. Principales actions

- **Au Bas-Uélé, déploiement** des équipes de surveillance à Ganga et à Viadana pour le suivi des contacts, la vérification des alertes et la recherche active, appui à l'enregistrement des membres du SGI, de la sécurité et de la coordination stratégique, et poursuite de la réhabilitation de la salle de réunion et des bureaux de la DPS ainsi que de la construction du centre de transit de l'HGR de Buta, dont les murs de pourtour sont achevés.
- **À la Tshopo, élaboration** de la check-list du monitoring logistique, suivi de la construction du CTE de Bafwasende et de l'isolement de Konga-Konga, extension du CTE Météo (2 chambres finalisées sur 4 prévues) et appui à la mobilité des piliers PCI, PEC, Communication et PoE/PoC ; le besoin en mobilité des ZS reste estimé à 154 motos.
- **En Ituri, 17** ambulances sur 33 ont été mobilisées et 21 patients ont été évacués vers les structures de prise en charge.

- **Au Nord-Kivu**, 5 maisonnettes ont été montées sur le chantier du CTE de Musienene, les travaux d'élargissement du CTE de Katwa se sont achevés avec la pose des portes et des vitres, et les médicaments et intrants PCI offerts par l'UG-PDSS ont été livrés aux ZS de Musienene et de Masereka.

2.11. Sécurité

2.12. Principales actions

- **Au Nord-Kivu**, les forces de sécurité ont accompagné l'équipe EDS pour l'enterrement de 2 cas confirmés au cimetière public de Bundji, les équipes PCI pour la décontamination du CM Emmanuel Dalson (AS Tamende), du CS La Grâce (AS Beningule), du CS Kasanga et d'un ménage de l'AS Kasanga, ainsi que les équipes EDS pour le swab de 2 décès communautaires à Kavisa et Rugenda (ZS de Katwa) ; la menace sécuritaire persiste contre les prestataires des PoC de l'axe Butembo.

2.13. PSEA (Prévention de l'Exploitation et Abus Sexuels)

2.13.1. Principales actions

- **En Ituri**, 12 commerçants (7 hommes, 2 femmes, 2 filles et 1 garçon) ont été sensibilisés sur la PSEAH dans la ZS de Bunia et l'affichage des messages ainsi que la distribution des dépliants se sont poursuivis à Bunia, Aru, Mongbwalu, Mambasa et Fataki ; seules 13 ZS sur 36 (36,1 %) connaissent le mécanisme de signalement.
- **Au Haut-Uélé**, 190 élèves et enseignants de l'ITM d'Isiro, 22 membres de la Croix-Rouge de Wamba, qui ont signé le code de bonne conduite, 10 taximen de Wamba et 7 réparateurs de motos de Boma Mangbetu ont été sensibilisés sur la PSEA et le circuit de signalement aux numéros verts (495555/151) ; les 6 ZS couvertes connaissent le mécanisme de signalement (100 %).

2.13.2. Défis

Au niveau national, seule 1 DPS sur 7 (14,3 %) a rapporté ses activités PSEA ; en Ituri, les activités ne couvrent pas encore toutes les ZS touchées, les supports de sensibilisation de masse manquent et la cartographie des intervenants reste incomplète.

MESSAGES CLÉS

- Dans les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Haut-Uélé, il s'observe une transmission communautaire active tandis qu'une notification sporadique est observée dans la province de la Tshopo.
- 2. Au cours des dernières 24 heures.
- Au cours des dernières 24 heures, tous les cas suspects (100,0%) ont été investigués ; des performances consolidées au regard des données transmises par les provinces. Cependant, le suivi des contacts demeure fluctuant (80,4 % vs 79,7 %) et mérite une attention particulière afin d'éviter des chaînes de transmission non contrôlées. Maintenir un niveau de vigilance en ce qui concerne les aspects de surveillance épidémiologique, consolider les actions PCI et CREC au niveau des communautés tout en offrant des soins de qualité dans les structures de prise en charge dédiées avec des capacités d'accueil adéquates.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17^e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.



TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17

Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : dieudonne.mwamba@insp.cd

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Chargé des opérations

Dr KOMBE NGWAMA John

Equipe de rédaction

Professeur Dr MULANGU KATULUMBA Félix-Médard

Dr KATUSI BISELENGE Jules

Madame MAYELE AFUA Marie

Dr DIUR MANANASHI Floryan

Mr KAMUINA KEBELA John

Contact :

www.insp.cd

contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151. www.sante.gouv.cd